

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

Durch den Kontakt der Haut mit Urin und Stuhl kann es zu schmerzhaften Entzündungsprozessen der Haut kommen – zur Inkontinenz-assoziierten Dermatitis. Windeldermatitis, Windelausschlag, Windelallergie – im Volksmund hat die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) viele Namen. Erstmals wurde 2014 im Expertenstandard zur Förderung der Harnkontinenz in der Pflege auf die Hautgefährdung durch Inkontinenz verwiesen und der Begriff der IAD eingeführt. Geprägt wurde er 2005 in einer Expertenrunde von Wissenschaftlern und klinischen Experten in den USA. Die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis ist eine irritative Kontaktdermatitis, bei der es durch Kontakt der Haut mit Urin und Stuhl zu schmerzhaften Entzündungsprozessen der Haut kommt. Je länger der Kontakt mit der Haut besteht, umso größer ist das Risiko für eine IAD.

Die lokalen Hautveränderungen hängen vom Ausmaß der Schädigung ab. Folgende Veränderungen sind zu beobachten:

- Flächige Rötung (rosa bis hochrot) mit diffusen Rändern zur Hautumgebung
- Schwellung
- Evtl. Blasen mit serösem Exsudat —Evtl. blutende Areale
- Evtl. oberflächliche Hautdefekte
- Erhöhte Hauttemperatur im Vergleich zur nicht betroffenen Haut
- Evtl. sekundäre Hautinfektion (z.B. Staphylokokken)

Die Hautveränderungen gehen mit Schmerzen einher, sie beeinträchtigen die Lebensqualität.

Prävalenz und Inzidenz dieser Hautveränderungen sind nicht vollständig gesichert. Sie variieren international in verschiedenen Studien zwischen 5,6% und 50% Prävalenz und Inzidenz zwischen 3,4% und 25%. IAD kann sich gleichermaßen bei Patienten in Akutpflegeeinrichtungen und bei Bewohnern von Pflegeheimen entwickeln. In einer Studie von 2021 in 47 deutschen Pflegeheimen und sieben Krankenhäusern ergab sich eine IAD-Prävalenz in Pflegeheimen von 4,4%, in Krankenhäusern von 12%. Die IAD kommt also bei Erwachsenen durchaus häufig vor. Nicht alle Menschen, die unter Inkontinenz leiden, entwickeln eine IAD, es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Gefährdet sind Personen mit:

- Stuhl- und Doppelinkontinenz
- Hoher Defäkationsfrequenz von flüssigem Stuhl $\geq 3x/24$ Std.
- Eingeschränkter Mobilität und/oder Sensorik
- Schlechtem Gesundheitszustand/Ernährungszustand
- Trockener, vulnerabler Altershaut (Hautbarriere im Alter geschwächt, Regeneration verlangsamt)
- Individuellen Hautveränderungen

Der Entstehungsmechanismus einer IAD ist noch nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um ein multifaktorielles Geschehen. Folgende Faktoren sind zu nennen:

Hyperhydration: Durch zu viel Feuchtigkeit (z.B. Urin/Stuhl, Okklusion durch Hilfsmittel) weicht die oberste Schicht der Epidermis auf und verliert ihre Barriere-/Schutzfunktion.

Physikalische Irritationen: Die feuchtigkeitsgeschädigte Haut ist sehr verletzlich gegenüber Reibung. Sie kann entstehen beim Waschen und Trocknen der Haut, außerdem durch Reibung im Kontakt zu saugenden Hilfsmitteln, zu Kleidung und/oder Sitz- und Liegeflächen.

Chemische Irritationen: Der als Abbauprodukt des Urins entstehende Ammoniak verändert den pH- Wert der Haut von ca. 5 pH (sauer) auf 6–7 pH (alkalisch). Neben diesen pH-Wertveränderungen schädigen zusätzlich Eiweiß- und Fettsäure spaltende Enzyme des Stuhls die Haut. Die Barriere-/Schutzfunktion verringert sich weiter. Auch vermehrte Reinigungsprozeduren spielen eine Rolle.

Biologische Irritationen: Durch die reduzierte Schutzfunktion entsteht eine verminderte Abwehr gegenüber einer pathologischen Keimbesiedlung. Die Gefahr einer möglichen Sekundärinfektion zum Beispiel mit Candida oder Staphylococcus aureus nimmt zu.

IAD oder Dekubitus?

Handelt es sich bei der auftretenden Hautrötung im perianalen Bereich um eine IAD oder einen Dekubitus?

Diese pflegerische Einschätzung müssen Pflegende treffen; dazu bedarf es einer speziellen Kompetenz.

Feuchtigkeit und wiederholter Harn- und Stuhlkontakt sind die zentralen Ursachen einer IAD. Es handelt sich um eine „top-down“-Läsion. Für die Entstehung eines Dekubitus sind der Druck bzw. die Druckverweildauer verantwortlich. Sie führen zu einer ischämischen Läsion, aus der eine Nekrose/ein Geschwür folgen kann. Die Gewebeschäden entstehen über Knochenvorsprünge, es geht um eine „bottom-up“-Läsion. Pflegende müssen in dieser Unterscheidung gut geschult werden.

Einschätzen einer IAD

Eine strukturierte Erfassung der IAD gilt als Voraussetzung, um angemessene pflegerische Strategien zu entwickeln. Liegt keine Inkontinenz (Harn- und Stuhlinkontinenz) bei einer Person vor oder werden die Ausscheidungen abgeleitet ohne dass Hautkontakt entsteht (z.B. Fäkalkollektor), kann die Diagnose IAD nicht gestellt werden.

Pflegerische Interventionen

Ohne Inkontinenz keine IAD, das ist die entscheidende Einschätzung. Nach der Ermittlung der Art, Häufigkeit und Dauer der Inkontinenz liegt die Prävention besonders darin, die Kontinenz zu fördern. Diese wird im nationalen Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz in der Pflege (DNQP, 2014) beschrieben. Auf die Stuhlinkontinenz als Risikofaktor für die IAD wird hier nicht eingegangen, sie bedarf der besonderen Aufmerksamkeit. Innerhalb der Anamnese stehen die genannten Risikogruppen im besonderen Fokus der Pflegenden. Zu prüfen ist, ob durch entsprechende Maßnahmen an den individuellen Risikofaktoren Verbesserungen erreicht werden können. Zu nennen sind beispielsweise die Verringerung der Defäkationsfrequenz und der Einwirkungszeit der Ausscheidung auf die Haut.

→ *Entscheidend ist das Fernhalten der Ausscheidung von der Haut.*

Lokale Maßnahmen

Lokale Maßnahmen in den gefährdeten Hautarealen und der entsprechende Hilfsmiteinsatz orientieren sich an den auslösenden Faktoren. Häufiges Waschen der betroffenen Hautareale ist zu hinterfragen. Schonende Reinigung muss nach jeder Stuhlausscheidung, aber nicht nach jeder Urinausscheidung erfolgen. Dabei sind weiche Materialien vorsichtig, ohne starkes Reiben/Rubbeln einzusetzen. Wasser sollte eher sparsam zur Reinigung verwendet werden. Lauwarmes oder kühles Wasser ist zu bevorzugen, zu warmes Wasser entfettet die Haut zusätzlich.

Einen wirksamen Schutz bieten die zur Kompensation der Ausscheidung eingesetzten körpernahen saugenden Hilfsmittel. Die Auswahl der richtigen Größe und Saugstärke sowie eine korrekte Anlegetechnik verhindern zusätzliche Reibung an der Haut (DNQP, 2014). Die Hilfsmittel werden gewechselt, wenn deren Aufnahmekapazität erreicht ist. Für Männer kann der Einsatz eines Kondomurinals (Foto 1) in Betracht gezogen werden. Bei Diarrhöe kann möglicherweise ein Fäkalkollektor (Foto 2) die Haut vor flüssigem Stuhl schützen. Bei den körperfernen, saugenden Hilfsmitteln ist auf atmungsaktive Produkte zu achten.

Für die Hautreinigung eignen sich pH-neutrale Reinigungsprodukte, sparsam eingesetzt. Sie liegen nahe dem Hautoberflächen- pH-Wert. Die „klassische“ Seife ist alkalisch und deshalb nicht zu verwenden. Die waschaktive Substanz darf nicht auf der Haut bleiben.

Zur Rückfettung der Haut empfiehlt sich eine Wasser-in-Öl-Lotion (W/O) möglichst ohne aggressive Konservierungsstoffe und ohne allergene Duftstoffe. Die Reinigungs- und Pflegeprodukte sind nach dem Haut- typ/Erscheinungsbild zu wählen.

Spezielle Barriersubstanzen können den Kontakt zwischen Ausscheidung und Haut bei inkontinenten Personen herabsetzen und dadurch eine Irritation der Haut verzögern oder verhindern. Es gibt inzwischen zahlreiche Produkte (Hautprotektoren oder Barriersubstanzen) in verschiedenen Applikationsformen zum Beispiel als Creme oder Spray. Sie wirken zum Teil zwischen sieben und 72 Stunden.

Foto Kondomurinal:

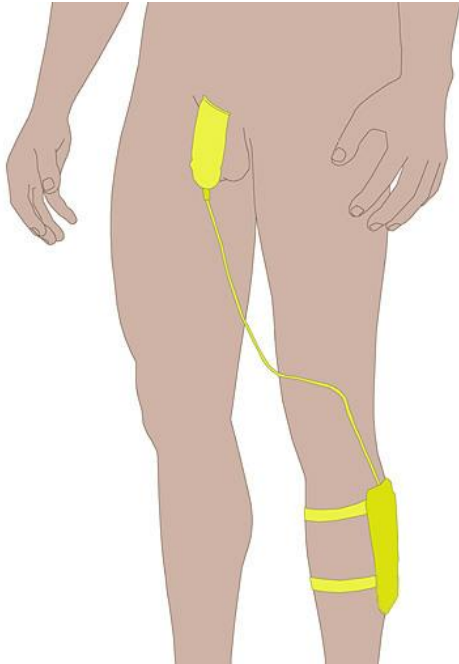


Foto Fäkalkollektor:



Foto IAD Gesäß:



Foto IAD Kleinkind:

